공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-053호 2012. 4. 24.

사 건 번 호 2010서경3039

사 건 명 진양제약(주)의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 진양제약 주식회사
서울 서초구 서초동 1532-9
대표이사 최재준
대리인 법무법인 광장
담당변호사 정진환

심 의 종 결 일 2012. 2. 24.

주 문

1. 피심인은 자기가 제조 또는 공급하는 의약품의 처방·판매 증진의 목적으로 의료법 제2조 소정의 의사 또는 의료법 제3조 소정의 의료기관에게 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대하게 현금·상품권 지급, 골프 및 식사 접대, 학회활동비 지원, 세미나 명목의 식사지원, 물품 지원 등 경제상 이익을 제공 또는 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 146,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 크리빅스정, 옥티란정, 리베라정 등 의약품을 제조·판매하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당하고, 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립일자	자본금	매출액	당기순이익	상시종업원수
1971.7.1.	6,000	40,856	3,171	241

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 피심인의 제품 현황 및 거래처 현황

2 피심인이 제조·판매하는 주요 제품 현황은 <표 2>와 같으며, <표 3>에서 보는 바와 같이 2010년 말 현재 104개 품목의 전문의약품과 56개 품목의 일반의약품을 취급하고 있다.

<표 2> 피심인의 주요 제품현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	제품명	2010년 매출액	매출 비중
순환기 품목 (내분비)	크리빅스	4,334	10.6
	조바틴	1,357	3.3

	디란트	908	2.2
	카자탄	531	1.3
	베스디핀	386	0.9
	액토그린	153	0.4
소화기 품목	리베라	1,352	3.3
	옥티란	962	2.4
	라미스타	896	2.2
기타 품목	지노드론	721	1.8
	세론	559	1.4
	도라셋	287	0.7
	이나졸	125	0.3
총 계		12,571	30.8

* 자료출처 : 피심인 제출자료

<표 3> 피심인의 취급 의약품수

(단위 : 개)

구 분	2008년	2009년	2010년
전문의약품(ETC)	109	106	104
일반의약품(OTC)	57	55	56
계	166	161	160

* 자료출처: 피심인 제출자료

3 피심인의 거래처 현황은 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 피심인의 거래처 현황

(2010. 12. 31. 기준)

구 분	거래처별	거래처수(개)
전문의약품(ETC)	종합병원	79
	병원	342
	의원	2,824
	보건소	97
일반의약품(OTC)	일반도매, 약국	3,951
계		7,293

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 개관

4 제약산업은 의약품을 개발·제조하여 유통하는 산업으로서, 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 구분되며, 완제의약품은 다시 일반의약품과 전문의약품으로 나뉜다. 일반의약품(Over-the-counter drug)은 의사의 처방 없이 약국에서 직접 구입할 수 있는 의약품이며, 전문의약품(Ethical drug)은 사람에게 위해를 가할 우려가 있거나 용법 또는 용량에 대한 전문적 지식을 필요로 하는 의약품으로서 의사의 처방을 통해서만 구입이 가능한 의약품을 말한다.

2) 제약산업의 특성

가) 규제산업

5 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 국가가 제품의 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있다.

나) 기술 및 지식 집약적 산업

6 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 고부가가치를 창출하는 미래성장산업으로 분류되고 있다. 신약개발에는 약학, 화학, 생물학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 기술의 토대위에 막대한 비용과 시간 투입이 필요하며, 1개의 신약을 개발하는데 10~15년 정도의 오랜 기간이 소요되며 연구개발(R&D) 비용은 보통 1억~5억 달러 정도 소요되고 있다.

7 1987년 국내에 물질특허제도[1)]가 도입되었고 이에 따라 특허를 받게 되는 신약은 20년간 독점적 지위를 보장받을 수 있다. 의약품은 특허 출원을 한 후에도 허가

1) 정부가 1986년 특허법을 개정하여 물질발명에 대하여는 특허가 부여될 수 없다고 하는 예외규정을 삭제함으로써 1987년부터 인정되게 된 물질특허는 화학적 방법에 의해 제조되는 물질의 발명에 부여되는 특허로서, 일반특허와는 달리 특허의 대상이 되는 물질의 용도를 특정할 필요 없고 특허권자는 그 물질에 관한 새로운 용도나 제법을 발명한 모든 후속 발명자에 대하여 원특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다.

등을 위한 임상시험에 장기간이 소요되므로 실질적으로 특허를 누리는 기간은 20년 미만이나, 신약 시판 후 부작용을 모니터링 하는 신약 재심사 기간(4~6년) 동안은 복제 의약품(제너릭, generic)의 허가를 해 주지 않으므로 사실상 특허기간이 연장되는 효과가 있다.

다) 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장

8 전문의약품은 일반상품과 달리 제품의 최종선택권이 비용지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있다.

9 또한, 대학병원, 종합병원 및 준종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C : Drug Committee)를 개최하여 '처방약제리스트'를 작성하는데 이 리스트에 등재되지 않은 의약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못한다.

10 따라서, 제약회사들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있다. 즉, 처방권한을 가진 의사들에게 자사제품에 대한 지식 전달 및 설명[2]을 실시하는 한편, 대학병원, 종합병원, 준종합병원의 처방약제리스트에 자사 의약품이 등재될 수 있도록 해당 병원의 약제심사위원들에게 자사 의약품에 대한 설명을 실시하고 있다.

라) 일반 제조업에 비해 판매관리비 과다

11 제약회사의 판매관리비는 2009년 기준으로 매출액의 36.59%에 달하는바, 일반 제조업의 판매관리비 비중(11.31%)에 비해 매우 높다.[3] 이는 제약회사들이 연구개발을 통한 제품의 질 경쟁보다 의사에 대한 판촉활동에 치중하고 있기 때문이다.

3) 제약시장 현황

2) 이를 '디테일(detail)'이라고 부르기도 한다.
3) 한국은행 2009년 기업분석 자료 참조

12 2009년 국내 의약품[4] 제조 규모는 약 15조 8,196억 원으로 전체 GDP의 약 1.49%를 차지하고 있으며, 이 중 완제의약품 제조 규모는 13조 3,667억 원, 원료의약품 제조규모는 1조 4,126억 원, 의약외품 제조규모는 1조 312억 원이다.

13 완제의약품 시장에 대해 살펴보면, 2009년 완제의약품 제조업체 수는 266개, 제조되는 품목수는 총 16,225개이며, 제조액을 기준으로 할 때 전문의약품이 전체 완제의약품의 80.9%를 차지하고 있다.

14 완제의약품 제조에서 상위 10대 기업의 시장점유율이 36.2% 수준으로 전체적으로는 경쟁적 시장구조이나, 전문의약품 시장에서 약효군별로 시장을 획정할 경우 일부 약효군에서 독과점적 구조가 나타나고 있다.

15 의약품 수요측면에서는 아래 <표 5>의 내용과 같이 2009년도 국민 전체 약제비가 13조 173억 원으로 총 진료비 46조 755억 원의 28.3%를 차지하였다.

16 2002년부터 2007년 사이의 5년 간 우리나라 약제비 증가율은 9.7%로 OECD 평균인 4.2%보다 높게 증가하고 있어 건강보험재정에 악영향을 미치고 있다. 이는 고령화 진입에 따른 만성질환자수 증가, 신약 등 고가 약으로의 처방전환, 제약사의 과도한 판촉활동에 따른 불필요한 처방증가 등에 의한 것으로 분석되고 있다.

<표 5> 연도별 진료비 및 약제비 현황

(단위: 조 원, %)

구 분	2007년	2008년	2009년
총진료비	37.9	41.2	46.1
총약제비(구성비)	10.8(28.5)	11.7(28.3)	13.0(28.3)

* 자료출처: 건강보험심사평가원

4) 제약산업의 유통구조

4) 완제의약품, 원료의약품, 의약외품, 마약, 한외마약, 향정신성의약품을 모두 포함한다.

17 국내 의약품 유통시장 규모(제조·수입실적 기준)는 2009년 기준으로 총 16조 7천억 원이며, 이 중 제약회사와 요양기관(병·의원, 약국, 보건소 등) 사이의 직거래를 제외한 도매거래 시장규모는 13조 3,703억 원으로 전체 유통시장의 78.4%를 차지하고 있다.

18 국내 의약품 유통 체계는 ①도매업체를 경유하는 방식과 ②제약회사가 직접 요양기관과 직거래하는 방식의 이원적 유통체계이며, 1994년도부터 100병상 이상 종합병원에 대해 도매업체 의무경유제도를 실시하고 있다.

19 의약품도매업체는 2010년 기준으로 1,944개이며, 도매업체 중 매출액 상위 10개 업체가 전체 도매시장 매출액 13조 3,703억 원의 29.1%를 점하고 있고, 2000년 1월 의약품도매업소 시설면적기준(영업소 및 창고) 폐지 이후 도매업체수, 특히 영세 도매업체수가 급증(2000년 700개 → 2010년 1,944개) 하였다.

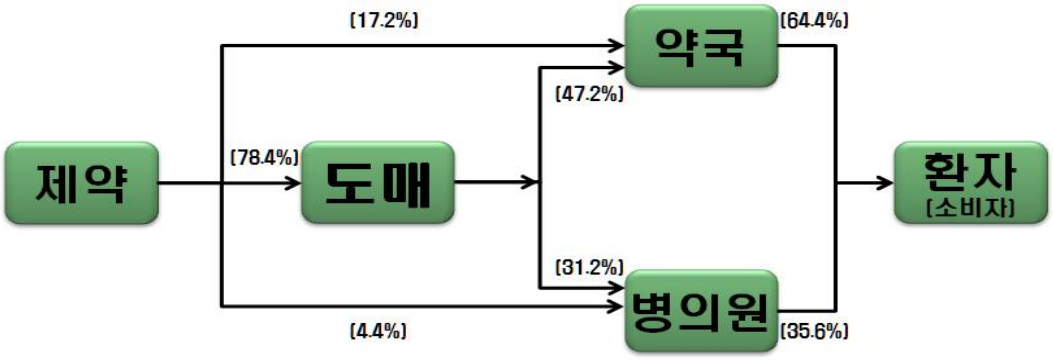
<표 6> 연도별 의약품도매업체수

(단위 : 개)

연도	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
도매업체수[5]	1,419	1,589	1,698	1,732	1,753	1,877	1,944

* 자료출처 : 한국의약품도매협회

<그림 1> 의약품의 유통구조



* 자료출처 : 건강보험심사평가원, 한국의약품도매협회

5) 한약도매업체는 제외

5) 제약산업의 규제현황

가) 의약품제조업 및 의약품도매업 허가

20 의약품 제조업을 영위하고자 하는 자는 제조 시설을 갖추어 식품의약품안전청장의 허가를 받아야 하며(약사법 제31조 제1항), 의약품도매업을 영위하고자 하는 자는 자산, 시설, 인력 등 일정 요건을 갖추어 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다(약사법 제45조 제1항). 약국 개설은 자연인인 약사 또는 한약사만 할 수 있으며(약사법 제20조 제1항), 약사・한약사는 1개소의 약국만 개설이 가능하다(약사법 제21조 제1항).

나) 의약품 품목 허가

21 의약품을 제조・판매하기 위해서는 품목별로 식품의약품안전청장의 허가를 받아야 하고, 품목허가 절차는 해당품목이 신약인지 복제약인지 여부에 따라 달라진다.

다) 광고규제

22 전문의약품은 대중광고가 금지되고, 의학 또는 약학에 관한 전문적・학술적 목적의 매체를 이용한 광고만 가능하다. 그러나 의약분업 실시 이후 처방전을 환자가 직접 볼 수 있게 되면서, 소비자(환자)가 복용하는 전문의약품에 대한 관심이 증대되고 있으며, 정보의 비대칭성 문제로 인해 광고규제에 대한 개선 움직임이 지속적으로 있어 왔다.

23 2007년 4월 타결된 한미 자유무역협정(FTA: Free Trade Agreement)에서 미국은 인터넷을 통한 의약품 정보제공 허용을 요구하였는데, 보건복지부는 현재 국내에서 허용되고 있는 바와 같이 제약회사의 홈페이지를 통한 정보 제공만을 허용하기로 하고, TV 등을 통한 전문의약품의 광고와 인터넷 포탈을 통한 의약품의 정보 제공은 허용하지 않기로 하였다.

라) 의약품 마케팅의 특징

24 의료서비스의 특성상 진료를 받는 환자가 의약품을 선택할 수 없는 상황에서 진료와 관련된 모든 선택은 의사가 하게 되고 제약업체는 의사들이 환자진료에 꼭 필요한 의약품을 제공하는 역할을 맡고 있다.

25 의사가 의약품을 구매·처방하는 행위는 상업적인 관계이기는 하나 기본적으로 환자를 위한 행위라는 측면에서 관계 당사자들의 이익을 최대화 하려는 일반 상업적 관계와는 큰 차이가 있다고 할 수 있다. 즉, 만일 의사와 제약업체 사이에 이루어지는 이런 상업적 행위가 환자에게 도움이 되기보다 의사나 제약업체에 더 이익이 되는 것이라면 이는 법적·윤리적으로 여러 가지 문제를 야기한다. 이에 따라 의약품의 공정한 거래를 위해 정부의 관리감독을 강화하고 관련단체 등에서 공정한 의약품 판매경쟁과 거래질서를 위한 규약을 만들어 제약회사들로 하여금 이를 지키도록 권고하고 있는 것은 전 세계 공통사항이며 불공정한 거래로부터 소비자인 모든 국민을 보호하고, 공정한 경쟁을 확보하기 위한 노력의 산물이다.

26 우리나라의 경우 대한의사협회 산하 공인학회의 숫자는 131개에 달하며, 제약회사는 학회에 대한 세미나 지원, 부스광고 등을 통해 자사제품 홍보 및 판촉활동을 하고 있으며, 주요병원 소속 의사이면서 주요학회의 임원을 맡고 있는 자들을 핵심인사(KOL: Key Opinion Leader)로 선정하여 강의료·자문료 지원, 시판후 조사 실시 등 다양한 방법의 지원을 통하여 자사 제품을 처방에 포함시키거나 구매하도록 유도하고 있다. 공인학회 이외에 각 지역 의사회, 연구회, 동문모임 등 비공식 모임에 대한 판촉활동도 이루어지고 있으나 그 규모 등은 현실적으로 파악이 어려운 상황이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 판매촉진계획의 수립

27 피심인은 2008년부터 2011년까지 아래 <표 7> 내지 <표 11>에서 보는 바와 같이 자기 의약품의 판매 증진 목적으로 처방액의 15 ~ 30%에 해당하는 금액을 의료법 제2조 소정의 의사나 의료법 제3조 소정의 의료기관(이하 의사나 의료기관을 함께 지칭할 때에는 '병・의원 등'이라 한다)에 지원하기로 하는 본사차원의 판매촉진계획을 수립한 사실이 있다.

<표 7> 「2008년 영업정책 수정 및 신설안」(발췌)

1. SP[6] 운영정책 1) 지원 대상품목 전체 EDI[7] 100만원 이상처는 20%, 미만처는 15%를 기본으로 지원함. 2) 핵심제품 및 전략제품은 EDI 금액에 따라 추가 10% 이내에서 특별 지원함. ① 핵심품목[8](크리빅스,조바틴,디란트) → 50만원 이상 처방시 10%이내에서 추가 지원 가능 대상 ② 전략품목(리베라,세론,라미스타,지노드론,미아릴,옥티란,지노큐,소부날200mg)→ 50만원 이상 처방시 5%이내에서 추가 지원 가능 대상 3) 특매처는 별도 계약 기준을 적용하고, 계약기간 중 모든 추가 특별지원 정책에서 제외함. 4) SP지원 대상품목은 2008년 선정된 cGMP 품목 중 2007년 연간 매출순위 50대 품목 및 신제품에 한함. ① cGMP 품목 : 78개 품목 중 2007년 연간 매출 50대 품목에만 지원함 (품목 및 규격 별도 지정) ② 신제품 : 2007~2008년 발매 신제품은 지원함. 5) 시행일정 : 2008년 1~3월 기간 계도 후 4월 1일부 전면 시행

6) 피심인의 영업본부장 서**의 진술(소갑 제9호증)에 의하면, SP는 Sample의 약자로 거래처에 선지원, 후지원 등의 방법으로 지원할 수 있는 판촉비를 의미한다.
7) EDI(Electronic Data Interchange) : '전자 문서 교환'의 뜻으로, EDI청구액은 의사가 의약품을 처방하고 건강보험심사평가원에 청구하는 금액을 의미한다.
8) 피심인의 영업본부장 서**의 진술(소갑 제9호증)에 의하면, 전략품목 및 핵심품목은 매출이 높고 원가가 낮으며 성장가능성이 있는 품목으로 집중 마케팅의 대상이 되는 제품이다.

<표 8> 「08년 크리빅스 영업지원정책안」(발췌)

2. 크리빅스 SP 선지급 정책
1) 대상
- 월 50만원 이상 처방처(기존 처방처 및 신규 처방처)
- 단, 기존 처방처는 계약 전월 처방대비 50% 이상 증량 가능처 대상
- SP 선지급은 약정 후, 처방이 시작된 기간(월)의 이행율 80% 이상 확인 후 집행
2) 기한 : 계약시점 기준 1/4분기
3) 방법 : 계약기간 10개월 이내로 30% SP 선지급 지원
4) 조건
- 크리빅스에 한함(타품목 제외)
- SP 선지급 지원시 영업본부와 사전협의. EDI 자료 반드시 첨부("08년 SP 운영정책" 적용)
- SP 선지급에 대한 이행율 80% 미만시 환수조치
5) 지원 : 물품, 여행 등으로 하고, 불가 시 자문료, 강의료 등 판촉비 증빙 각자 마련(방법은 본부와 상의)

<표 9> 「2008년 하반기 영업정책」(발췌)

Ⅱ. 2008년 하반기 영업 지원정책 요약

지원안	지원대상	지원내용(요약)	지원시기
1. SP 기본정책	처방처	43대 품목으로 월EDI 100만원 이상 20%, 미만 15%	7~12월
2. SP 추가 지원 정책	처방처	핵심. 전략품목 및 신제품에 대해 EDI 규모에 따라 5%, 10% 추가지원	7~12월
14. 신제품 SP 추가 지원 정책	처방처	월EDI 30만원 이상 5%, 100만원 이상 10%	9~12월
16. 세미나 지원	처방처	내과 중심 소그룹 세미나 지원(참석당 1인당 5만원 기준)	7~12월

Ⅴ. 기타 신제품 정책
1. SP 추가 지원
1) 대상 품목 - 이나졸, 카자탄, 엑토그린, 베스디핀, 도라셋
2) 기본 지원조건(15개, 20개)에서 상기 품목에 대해 EDI 30만원 이상시 5개, 100만원 이상시 10개를 추가 지원함.

Ⅷ. 공지사항
1. 처방처 판촉지원시 반드시 판촉 전보다 EDI가 증가해야 함. 미증가처는 지원대상에서 제외함. 품목교체 혹은 처방금액 상쇄를 적극 방지할 것.
2. 의원 그룹세미나는 참석한 비거래처 중 1개월내 30%이상 신규시 지원함.

하반기 세미나 지원은 지점(팀)별 상반기 세미나 결과를 기준으로 지원하며 세미나 후 신규.신투 및 처방증량 부진 지점(팀)은 지원 통제하겠음.

<표 10> 「2010년 사업계획」 발췌[9)]

9. 주요전략 - 주요제품 중심 지원 통해 기존처 처방증대 및 신규처 다수 확보 - 주요제품(esp. 신제품)의 종합병원 사업가능성 검토 및 지원 - 다처방처(당사 제품 300만원 이상처) 대상 차별화된 지원 - 주요제품 실전 디테일 화법 개발 및 교육 - 시장조사 등 병의원 방문활동 강화 위한 프로모션 tool 개발 - 처방증대 신규 가능처 중심 동행방문 등 현장지원 강화 - 병의원과 유대 증진 위한 고객감동 이벤트 등 감성마케팅 강화 10-1. 주요 활동계획 - 신규처 확보 위한 소모임 제품세미나 지원 - 개원가 Drs. 대상 시장조사(설문지 활용) 시행, 방문활동 강화 tool로 활용 - 다처방 유도 및 신규가능한 Drs. 대상 자문, 강연 요청 및 지원

<표 11> 「2011년 관리본부 사업계획」(발췌)

Ⅳ-2. 예산(SP)배정 규정 개정 1. 배경 - 1) 11월28일 쌍벌제 시행으로 SP 지급 개정 필요 2) 거래처에서 EDI 회수가 어려워질 경우 Hira 청구 데이터를 통한 예산 배정 2. 지원 - 1) 기본정책 - 2010년 지원 정책 유지(EDI 제출처) - EDI 500만 이상처 - 전 품목 20% 고정 지원

9) 피심인의 2009년 판매촉진계획은 발견되지 않았으나, 2009년 1~2월 중 피심인의 기안서(소갑 제6호증)를 살펴볼 때 '2008년 영업정책 수정 및 신설(안)' 등에 근거하여 예산을 집행한 점, '2008년 영업정책 수정 및 신설(안)'이 피심인의 SP 운영정책에 관한 기본지침 역할을 하고 있는 것으로 보이는 점(이는 <표 11>의 "1) 11월 28일 쌍벌제 시행으로 SP 지급 개정 필요"라는 문구를 통해 알 수 있다), 피심인의 각종 경제상 이익 제공 행태에 있어서 2008년 및 2010년과 대비해 2009년을 달리보기 어려운 점, 피심인의 영업본부장 서**의 진술(소갑 제10호증)에 의하면 "귀사의 2008년~2011년 영업계획서 등에 의하여 병의원 처방액의 대략 10%~25%를 SP 예산 지원하도록 되어 있는 바, 위 지원된 SP 예산은 어떻게 사용되는지"라는 질문에 서**는 "처방에 대한 대가로 해당 병의원에 대한 판촉비로 사용됩니다"라고 답한 점 등을 종합하여 보면 2009년도에도 피심인은 본사차원의 판매촉진계획에 의해 각종 경제상 이익제공행위를 하였음을 알 수 있다.

- 크리빅스 - 25% 지원, 500만 이상처는 20% 고정 지원
- 2품목 - 카자탄, 조바틴 20% 지원
- 전략 품목(18품목) - 20 % 지원
- 기타 품목 - 10% 지원

Ⅳ-3. 예산(SP) 관리

1. 등급별 처방처 예산 관리

500만원 이상처	500만 미만~200만원 이상	200만원 미만
영업본부 특별관리	사업부장 관리	지점(팀)장 관리

2) 판매촉진계획에 따른 지원 행위

가) 현금, 상품권 등 금품류 제공

28 피심인은 2008. 8월 ~ 2011. 1월까지, <별지 1>, <별지 2>와 같이 467개[10] 병·의원 등에게 자기 의약품 처방의 대가로 총 455,392천 원 상당의 현금 또는 대형마트 상품권 등을 제공한 사실이 있다.

29 이러한 사실은 피심인의 영업본부장 서**의 2011. 7. 14. 진술조서(소갑 제10호증) 및 2011. 8. 25. 진술조서(소갑 제17호증), 피심인의 소속 영업사원들이 병·의원 등에 현금을 지급하기 위하여 작성한 기안문(소갑 제11호증), 피심인의 예산집행 관련문서(소갑 제19호증) 등에 의하여 인정된다.

나) 골프 및 식사접대 등 향응 제공

30 피심인은 2008. 5월 ~ 2011. 1월까지, <별지 3>과 같이 약 26개 병·의원 등에게 자기 의약품 처방의 대가, 처방 증대 및 신규 랜딩 목적으로 총 9,704천 원 상당의 골프 및 회식접대 등을 제공한 사실이 있다.

10) 현금 등 지급 대상 22개<별지1>, 상품권 지급 대상 449개<별지2>(현금 등 지급과 상품권 지급이 중복되는 병·의원 등은 지급대상의 수를 합계함에 있어서 1번만 산정하였다)

31 이러한 사실은 피심인의 영업본부장 서**의 2011. 7. 14. 진술조서(소갑 제10호증) 및 피심인의 소속 영업사원들이 작성한 기안문 등(소갑 제13호증), 피심인의 예산집행 관련문서(소갑 제18호증) 등에 의하여 인정된다.

다) 커피자판기, 컴퓨터 등 물품지원

32 피심인은 2008. 6월 ~ 2011. 1월까지, <별지 4>와 같이 10개 병・의원 등에게 자기 의약품 처방의 대가, 처방 증대 및 신규 랜딩 목적으로 총 5,420천 원 상당의 LCD모니터, 커피자판기, 체육시설 등을 지원한 사실이 있다.

33 이러한 사실은 피심인의 영업본부장 서**의 2011. 7. 14. 진술조서(소갑 제10호증) 및 피심인의 소속 영업사원들이 작성한 기안문 등(소갑 제14호증), 피심인의 예산집행 관련문서(소갑 제18호증) 등에 의하여 인정된다.

라) 학회경비 지원 및 제품세미나 명목의 식사비 지원

34 피심인은 2008. 4월 ~ 2010. 5월까지 <표 12>, <별지 5>와 같이 자기 의약품 처방의 대가, 처방 증진 및 신규 랜딩 목적으로 해외학회 참석 의사의 경비(1,000천 원)를 지원하거나 의대 동문모임, 지역 병·의원모임 등 보건의료인 모임에 제품세미나 명목으로 총 31회, 23,260천 원 상당의 식사비용을 지원한 사실이 있다.

35 이러한 사실은 피심인의 영업본부장 서**의 2011. 7. 14. 진술조서(소갑 제10호증) 및 피심인의 소속 영업사원들이 작성한 기안문 등(소갑 제15, 16호증), 피심인의 예산집행 관련문서(소갑 제18호증) 등에 의하여 인정된다.

<표 12> 학회경비 지원현황

지원일자	지원대상	지원금액	지원내역
2008. 4. 25.	**병원 산부인과 한**교수	1,000천 원	미국 산부인과 학회 참석 지원

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1., 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 [별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

나., 다. (생략)

5. ~ 10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

36 법 제23조 제1항 및 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 제4호 가목에

따른 '부당한 이익에 의한 고객유인' 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여 둘째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써 셋째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공 또는 제공 제의인지 여부

37 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라서는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다. 또한 부당한 이익에 해당하는지는 관련 법령에 의해 금지되거나 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.[11)]

38 한편 제약산업에 있어서는 그 상품의 특성상 부당성 판단시 다음과 같은 점을 고려하여야 한다. 즉 일반상품과 달리 전문의약품의 경우 소비자인 환자가 자신이 어떤 상품을 구입할 것인지 선택할 수 없고, 의사가 처방해 준 의약품을 구입할 수밖에 없다는 점 때문에 소비자의 제품선택권이 제약되는 특징이 있으므로, 의사의 의약품선택이 의약품의 품질과 가격의 우수성에 근거하지 않고, 제약업체가 제공하는 부적절한 이익의 크기에 의존하게 된다면 소비자인 환자의 이익은 현저하게 저해되고 의약품시장에서의 건전한 경쟁은 기대할 수 없게 된다.

39 의약품 판매에서 정보제공활동과 설득활동은 필수불가결하다고 할 수 있으나, 의사가 의약품을 선택하는 데에 그 품질과 가격의 우위에 근거하지 않고 제약회사가 제공하는 부적절한 이익의 대소에 영향을 받게 된다면 소비자의 이익은 현저하게 침해될 수 밖에 없고 의약품 시장에서의 건전한 경쟁도 기대할 수 없게 되므로, 제약회사의 판매촉진활동은 이와 같은 측면들을 종합적으로 고려하여 투명성, 비대가

11) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2009누33777 판결 참조

성, 비과대성 등의 판단기준 하에 정상적인 거래관행에 비추어 보아 부당하거나 과대한 이익의 제공에 해당하는지 여부를 가려야 할 것이고, 이러한 판단 과정에서 한국제약협회가 제정한 보험용 의약품의 거래에 관한 공정경쟁규약은 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.[12)]

40 한국제약협회의 구 보험용 의약품에 관한 공정경쟁규약(이하 '구 공정경쟁규약'이라 한다)[13)]에 따르면 병·의원 등에 대한 금품류 제공은 처방을 대가로 이루어져서는 아니되며, 병·의원 등에게 금품류를 제공하는 행위를 예외적으로 허용하고 있으나 그 단서로 사회통념에 비추어 과대하지 않을 것을 요구하고 있다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

41 경쟁사업자의 고객이란 경쟁사업자와 실제로 거래하고 있는 고객뿐만 아니라 장래에 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 잠재적 고객도 포함한다.[14)]

42 또한, 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없고 객관적으로 고객의 상품구매결정에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으면 고객유인가능성을 인정할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

43 공정거래저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래저해성이 있다 할 것이고, 경쟁저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성) 만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.[15)]

---

12) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두3507 판결 참조
13) 2001. 12. 18. 개정된 것을 말한다. 이후 구 공정경쟁규약은 2009. 12. 22. 개정되었으며, 2010. 12. 17. 다시 개정되어 현재에 이르고 있는바, 병·의원 등에 대한 금품류 제공이 처방을 대가로 이루어져서는 아니되고, 허용되는 금품류 제공행위도 사회통념에 비추어 과대하지 않을 것을 요구하는 것에는 변함이 없다.
14) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결 참조

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공 또는 제공 제의인지 여부

44 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

45 첫째, 사업자가 고객의 수요를 얻기 위하여 가격, 품질 또는 서비스 등 장점에 의한 경쟁(competition on merits)을 하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이나, 피심인은 병·의원 등에게 현금・상품권 등 지급, 골프 및 식사접대, 커피자판기, 컴퓨터 등 물품지원, 학회경비 지원 및 제품세미나 명목의 식사비 지원이라는 불공정한 경쟁수단을 사용하였다.

46 둘째, 피심인이 환자진료와는 관계가 없는 현금・상품권 등 지급, 골프 및 식사접대, 커피자판기, 컴퓨터 등 물품지원, 학회경비 지원 및 제품세미나 명목의 식사비 지원 등 경제상 이익을 병·의원 등에게 제공한 이유가 병·의원 등에 대하여 자기의 의약품의 우수성을 설명하는 등 정상적인 판촉활동을 하기 위한 것이라기보다는 경쟁을 회피하여 자기의 의약품만을 지속적으로 판매하기 위한 것으로 판단되는바, 이는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 거래관행으로 볼 수 없다.

47 셋째, 약사법 제47조[16] 및 같은 법 시행규칙 제62조[17]에 피심인과 같은 제약

15) 대법원 2001. 2. 9. 선고2000두6206판결 참조

16) 약사법 제47조(의약품등의 판매 질서) ② 의약품의 품목허가를 받은 자, 수입자 및 의약품 도매상은 의약품 채택・처방유도 등 판매촉진을 목적으로 약사・한약사(해당 약국 종사자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)・의료인・의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다) 또는 의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편익, 노무, 양응, 그 밖의 경제적 이익(이하 "경제적 이익등"이라 한다)을 제공하여서는 아니된다. 다만, 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위(이하 "견본품 제공등의 행위"라 한다)로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안에의 경제적 이익 등인 경우에는 그러하지 아니하다.

17) 약사법 시행규칙 제62조(의약품등의 유통체계 확립 및 판매질서 유지 등을 위한 준수사항) ⑤ 법 제47조제2항 단서 및 제3항 단서에서"보건복지부령으로 정하는 경제적 이익등"이란 별표 5의2와 같다.
[별표 5의2]허용되는 경제적 이익등의 범위(제62조제5항 관련)
4. 제품설명회
1. 사업자가 국내에서 복수의 요양기관을 대상으로 그 사업자의 의약품에 대한 정보제공을 목적으로 주최하는

회사는 병·의원 등에게 의약품 판매촉진목적으로 금전 등의 경제상 이익을 제공할 수 없음에도, 피심인은 병·의원 등에게 각종 경제상 이익을 제공함으로써 약사법을 위반하는 행위를 하였는바, 이는 관련 법령에 의하여 금지되는 부당한 이익을 제공한 것으로 인정된다.

48 한편, 피심인은 <별지 5>의 제품세미나 명목의 식사지원의 경우 판촉목적의 단순접대는 아니었고, 관련제품의 효능 등을 설명하는 제품설명회를 위한 것이었으며, 공정경쟁규약상 허용된 기준인 1인당 10만원 범위내에서 이루어졌다는 이유로 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공은 아니라고 주장한다.

49 살피건대, 약사법 시행규칙 제62조 제5항 [별표 5의2] 에 의하면 제품설명회는 의약품에 대한 정보제공을 목적으로 개최하는 것만을 말하며, 보건의료인의 모임 등에 필요한 식음료를 지원하기 위하여 개최하는 것을 포함하지 않음에도 <별지 5>의 개최장소, 개최시간, 품의목적[18], 모임성격 등을 살펴보면 제품설명회를 개최하였다기보다는 자사 제품의 처방 유지·증대 목적의 식사 접대를 한 것임이 명백하므로 피심인의 주장은 이유 없다[19].

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

50 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 경쟁사업자의 고

제품설명회에 참석한 의사·치과의사·한의사·약사 및 한약사(이하 이 표에서 "의사등"이라 한다)에게 제공하는 실제 비용의 교통비, 5만원 이하의 기념품, 숙박, 식음료(세금 및 봉사료를 제외한 금액이 1회당 10만원 이하인 경우로 한정한다)

2. 사업자가 개별 요양기관을 방문하여 의사등에게 그 사업자의 의약품에 대한 정보를 제공하는 방식으로 주최하는 제품설명회에 참석한 의사등에게 제공하는 1일 10만원 이하(월 4호 이내로 한정한다)의 식음료 및 자사의 회사명 또는 제품명이 기입된 1만원 이하의 판촉물

※ 제품설명회는 의약품에 대한 정보제공을 목적으로 개최하는 것만을 말하며, 「보건의료기본법」제3조제3호에 따른 보건의료인의 모임 등에 필요한 식음료를 지원하기 위하여 개최하는 것은 포함하지 않는다.

18) 기존거래처의 판매증대, 신규거래처 확보, 타사 방어 및 처방 증대, 처방활성화, 처방품목 증대 등(소갑 16호증 참조)

19) 한편, 공정경쟁규약(2009. 12. 22. 개정된 것) 제11조 1항 제3호에 의하면 사업자는 제품설명회 개최시 행사장소, 행사내용 및 개최방법 등이 불공정행위로 오해받지 않도록 유의해야 하는데, <별지 5>의 내역으로 미루어 피심인이 위 조항을 준수하였다고 보기 어렵고, 또한 같은 규약 제11조 제2항에 의하면 사업자는 사전에 협회에 제품설명회를 개최한다는 사실을 한국제약협회에서 정한 양식에 따라 신고하여야 하는바, 피심인은 이를 준수하였다는 증빙을 전혀 제시하지 못하고 있다.

객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 행위에 해당한다.

51 첫째, 국내에서 제조되는 의약품은 대부분 복제약에 해당하는바, 제약회사 간 의약품의 품질 차이가 크다고 보기 어려워, 피심인으로부터 각종 경제상 이익을 제공받은 병·의원 등이 의약품의 가격·안정성 및 효과 등을 환자별로 구체적으로 고려하여 처방·구매하기 보다는 단순히 피심인 등 제약회사로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하도록 하거나 그 가능성을 증대시킬 가능성이 높다.

52 둘째, 피심인의 위 2. 가.의 행위는 피심인의 본사차원의 판매촉진계획에 따라 계획적이고 의도적으로 실행된 것으로, 피심인이 경제적 이익을 제공하는 사유가 자기 의약품의 처방 대가, 처방 증진 등 처방·판매와 연계하여 반복적이고 지속적으로 제공하고 있다는 점에서 고객 유인 가능성이 크다고 볼 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

53 피심인의 위 2. 가.의 행위는, 앞서 살펴본 바와 같이 병・의원 등으로 하여금 의약품의 가격・안전성 및 효과 등을 고려하여 환자들에게 맞는 의약품을 처방・구매하도록 하기보다는 병・의원 등이 피심인으로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하도록 하고, 의약품 선택이 많으면 제약회사로부터의 이익 제공 규모가 커지게 되어 결과적으로 환자에게 도움이 되는 의약품보다는 병・의원 등이나 제약회사에 더 이익이 되는 의약품이 선택되는 선택왜곡 현상을 가져올 위험성을 배제하기 어려운 바, 소비자가 직접 의약품을 구매할 수 없는 제약시장의 특성, 피심인이 병・의원 등에게 제공한 이익 규모 등에 비추어 경쟁 수단 또는 거래내용이 정당하다고 보기 어려워 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다 할 것이다.

3) 결론

54 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호 전단, 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 불공정거래행위 유형 및 기준 제4호 가목의 부당한 이익에 의한 고객유인행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

55 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 크고 소비자에게 미치는 영향이 중대한 위반행위에 해당하므로, 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제24조에 따라 시정명령 및 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호, 이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (2)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금의 산정

가) 관련매출액

56 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[20]

57 제약회사가 의약품을 처방하는 의사 및 그 소속 의료기관 등에게 부당한 고객유인행위를 한 경우에 있어서는, 판매촉진계획 및 실제 이루어진 이익제공 행위의 대상·내용·액수·기간·지속성 및 관련성 등에 비추어 본사 차원에서 의약품별 판매촉진계획을 수립하여 전국적으로 시행한 것으로 볼 수 있는지 여부, 이익제공 행위의 구체적인 태양이 다르더라도 의약품 판매 증대를 위한 경제상 이익의 제공이라는 점에서 판매촉진계획 실행행위의 일부로 볼 수 있는지 여부, 이익제공을 위한 비용이

20) 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1) 참조

상품가격에 전가될 우려 및 정도, 판매촉진계획 및 이익제공 행위 적발의 난이도, 위반행위 당시의 거래관행 등의 여러 사정을 종합하여, 구체적으로 확인된 이익제공 행위가 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판매촉진계획의 실행행위로서 이루어진 것으로 평가할 수 있으면, 의약품을 제조·판매하는 사업자의 해당 의약품에 대한 거래처 전체의 매출액을 위반행위로 인하여 영향을 받는 관련상품의 매출액 즉, 관련매출액으로 보아야 한다.[21)]

58 살피건대, 피심인은 위 2. 가. 1)에서 보는 바와 같이 자사가 취급하는 의약품을 대상으로 본사 차원에서 처방 유지·증대 목적의 판매촉진계획을 수립하였고, 실행행위도 각각 태양은 다르더라도 이러한 판매촉진계획에 입각한 실행행위로서 병·의원 등에게 처방을 대가로 지속적으로 경제상 이익을 제공하였으므로 이 사건 관련매출액은 피심인의 위반행위와 관련된 크리빅스정 등 43개 의약품 전체의 매출액으로 보는 것이 타당하다.

59 관련매출액의 산정과 관련한 법위반행위의 시기는 해당 43개 의약품별로 경제상 이익을 최초로 제공한 날로 한다.

60 법위반행위의 종기는 해당 43개 의약품 별로 경제상 이익을 마지막으로 제공한 날로 한다.

61 따라서 위반기간 중 관련 의약품의 매출액 합계인 26,224,116천 원을 관련매출액으로 하고 그 구체적인 내역은 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 관련매출액

(단위 : 원)

연번	제 품 명	시 기	종 기	매출액
1	그린페지정(500mg)	2010-05-11	2011-01-31	205,115,000
2	나노프릴정	2010-05-11	2011-01-31	64,921,000
3	나레틸정	2010-05-11	2010-10-31	160,696,000

21) 대법원 2010.12.9. 선고 2009두3507 판결 참조

4	나릴정(10mg)	2010-05-11	2011-01-31	87,456,000
5	낙톤정	2010-05-11	2011-01-31	386,163,000
6	네오세프캡슐	2010-05-01	2011-01-31	718,073,000
7	뉴자틴캡슐150mg	2010-05-11	2011-01-31	295,433,000
8	다피드정2.5mg	2010-05-11	2011-01-31	355,895,000
9	도라셋정	2008-07-14	2011-01-31	624,575,000
10	디란트정25mg	2010-05-11	2010-10-31	563,492,000
11	디멘사정	2010-05-11	2011-01-31	206,026,000
12	라미스타정	2010-05-11	2011-01-31	677,459,000
13	레디핀정20mg	2010-05-11	2010-10-31	63,860,000
14	레부날정	2010-05-01	2011-01-31	350,306,000
15	레자딥정	2010-05-11	2011-01-31	238,908,000
16	리베라정	2008-04-24	2011-01-31	2,773,396,000
17	모리캄캡슐15mg	2010-05-11	2010-10-31	145,088,000
18	미아릴정	2010-05-11	2010-10-31	362,191,000
19	베스디핀정	2010-05-11	2010-10-31	186,030,000
20	베탁정(20mg)	2010-05-11	2010-10-31	125,607,000
21	보니드정	2010-05-11	2011-01-31	197,973,000
22	세론정	2010-05-01	2011-01-31	413,670,000
23	시메코판연질캡슐	2010-05-11	2011-01-31	123,582,000
24	씨록신정250mg	2010-05-11	2011-01-31	205,670,000
25	아엔탈정	2010-05-11	2010-10-31	98,877,000
26	액토그린정	2010-05-11	2011-01-31	112,856,000
27	엔티스캡슐	2010-05-11	2010-10-31	37,718,000
28	오구맥듀오건조시럽	2010-05-11	2010-10-31	131,326,000
29	오구맥정625mg	2010-05-11	2011-01-31	179,570,000
30	오구맥현탁정156.25mg	2010-05-11	2011-01-31	97,846,000
31	오구맥현탁정250mg	2010-05-11	2011-01-31	71,127,000
32	옥티란정40mg	2008-05-17	2011-01-31	1,563,747,000
33	이나졸정200mg	2008-10-17	2011-01-31	233,964,000
34	조바틴정20mg	2010-05-11	2011-01-31	848,956,000
35	지나시드건조시럽(400mg)	2010-05-11	2011-01-31	353,750,000
36	지노드론정70mg	2010-05-01	2010-10-31	307,477,000
37	지노메디츄어블정	2010-05-11	2011-01-31	177,044,000

38	진양아시클로버정400mg	2010-05-11	2011-01-31	123,641,000
39	진양에페리손정	2010-05-11	2011-01-31	313,219,000
40	진프라그정	2010-05-11	2010-10-31	63,307,000
41	카자탄정	2010-05-01	2010-10-31	271,277,000
42	크리빅스정	2008-04-24	2011-01-31	11,476,321,000
43	탈니프정	2010-05-11	2010-10-31	230,508,000
	합 계			26,224,116,000

나) 부과기준율

62 위반행위의 내용, 경제상 이익을 제공받은 병·의원 등의 수, 피심인과 병·의원 등 사이의 거래행태 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하여 0.8% ~ 1% 범위 내의 부과기준율을 적용할 수 있는바, 경제상 이익 제공 규모가 크지 아니한 점을 고려하여 0.8%의 부과기준율을 적용한다.

다) 기본과징금

63 기본과징금은 관련매출액에 부과기준율을 곱한 209,792,928원이다.

2) 의무적 조정과징금의 산정

64 의무적 조정과징금 가중 사유가 없으므로 기본과징금과 같은 209,792,928원을 의무적 조정과징금으로 한다.

3) 임의적 조정과징금의 산정

65 피심인은 이 사건 조사단계부터 위원회 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하고 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 의무적 조정과징금의 30%를 감경한 146,855천 원을 임의적 조정과징금으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

66 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 임의적 조정과징금의 백만 원 미만 금액을 버린 146,000천 원을 최종 부과과징금으로 한다.

4. 결론

67 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금부과에 대해서는 법 제24조의2를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 4월 24일

의 장	위 원	김 학 현
	위 원	장 용 석
	위 원	최 종 원